

CUARTA PARTE

PARANOIAS

VIGENCIA CLÍNICA, VARIEDADES, CRÍTICAS

Julia Martin

(coordinadora)

CAPÍTULO 14

Introducción

Julia Martín y Nicolás Maugeri

Si yo fuera juez, diría que Barreda
es un hombre inocente,
que aguantó y no pudo más.

Ricardo Barreda, en su juicio oral y público, 1995

La dilución de las paranoias en las clasificaciones actuales

El 15 de noviembre de 1992, el odontólogo platense Ricardo Barreda asesinó con un arma de fuego a las cuatro mujeres de su familia: su esposa, sus dos hijas y su suegra. El caso conmovió a la comunidad en su conjunto: su debate mediático no hizo más que dejar traslucir las complejidades inherentes a su juzgamiento. Es que el discurso de este hombre produjo tanto empatía generalizada como rechazo: “No estoy arrepentido. Me habían declarado la guerra. Así no podía seguir viviendo. Si las circunstancias se volvieran a repetir, no dudaría en hacer lo mismo” (Barreda, 1995: 59). Barreda produjo por aquel entonces un efecto curioso en gran parte del público que siguió su juicio: una cierta conmiseración y piedad por un hombre que habría sido supuesto objeto de innumerables maltratos por parte de sus mujeres, esas a las que llamó “los cuerpos”, cuando intentó encubrir los asesinatos esgrimiendo que las había encontrado muertas en ocasión de un robo.

Luego de la disputa acerca del diagnóstico psiquiátrico del agresor en el seno del ámbito pericial -resumida en dos posiciones irreconciliables: delirio de reivindicación vs. personalidad obsesiva y narcisista-, el mismo fue hallado culpable de homicidio múltiple interfamiliar y condenado a prisión perpetua. La discusión giró en torno a su imputabilidad: si se admitía el componente paranoico, se ponía en jaque su responsabilidad en los actos criminales. Este deslizamiento –el esfuerzo porque el diagnóstico psiquiátrico encastrase en el argumento de la atribución de la responsabilidad penal- empantanó, en gran parte, la discusión clínica (Martín, 2018). Porque como veremos, para los denominados “clásicos de la paranoia,” como Kraepelin, Gaupp o Gatan de Clérambault, el delirio puede convivir con la denominada “claridad del pensamiento y la acción”.

Si bien por mucho tiempo Ricardo Barreda fue considerado un héroe en la cultura popular machista (Giberti, 2011) -expresión de la banalización con que el asunto se ha tratado-, veinte años después del crimen, en noviembre de 2012, la casa del odontólogo se expropia para convertirse en un centro de referencia sobre la violencia contra las mujeres. Se sanciona la Ley Nacional 26.791 que modifica el artículo 80 del Código Penal para castigar especialmente los asesinatos de mujeres con las que se tiene o se ha tenido un lazo familiar o de pareja. En este contexto de transformación, Barreda es renombrado como *femicida* en textos académicos (Giannoni, 2012; Lombardi & al., 2015). La discusión sobre el elemento psicopatológico encuentra, por tanto, su vigencia. Casos como el de Barreda, quizás no tan resonantes, se reiteran en los juzgados, en los hospitales y demás instituciones. Son casos que precisamente ponen en jaque al sentido común que considera a la locura como la expresión de un desorden exagerado y visible, caracterizado por las alucinaciones y el delirio.

El objetivo de esta parte del libro es reintroducir y sistematizar algunos de los desarrollos esenciales de grandes clínicos clásicos que han tratado de delimitar a la paranoia como un modo de padecimiento y de estar-en-el-mundo diferenciado de la esquizofrenia y de la melancolía. Presentaremos las dificultades principales de este esfuerzo de delimitación en las corrientes suizo-alemana y francesa. Nos detendremos en caracterizar sus formas delirantes y lo que se ha dado en llamar "carácter paranoico", en tanto revalorizamos la riqueza clínica de estas descripciones y su vigencia en las modalidades del malestar actual. Consideramos que la dificultad de precisar criterios de inclusión y exclusión para definir este campo clásicamente nombrado como "paranoia" no puede ir en desmedro de ubicarla efectivamente como un tipo particular de padecimiento. Los ejes de discusión, en torno a la curabilidad-incurabilidad; el lugar de las formas querulantes; de la afectividad; la diferenciación en torno a los mecanismos; las formas procesuales distinguidas de la "constitución paranoica", dan cuenta que, en definitiva, hay, como supo esbozar el genio de Gatan de Clérambault,⁵⁸ las paranoias, en plural. Sobre estas variedades, es necesario identificar lo cardinal, lo patognomónico, lo distintivo. Es ése el desafío.

La apuesta de esta parte del libro requiere de un gran trabajo de reconstrucción y síntesis. A diferencia de la esquizofrenia -que monopolizó los diagnósticos actuales en los manuales americanos-; o de la psicosis maníaco-depresiva -que tuvo su momento de auge con la llegada de los estabilizadores del ánimo-, la paranoia en cambio desapareció directamente de los manuales diagnósticos y estadísticos contemporáneos. A continuación, revisaremos brevemente lo que resta de la categoría de paranoia en estos manuales, con el fin de que el lector pueda encontrar elementos para tomar posición acerca de la necesidad - o no - de recuperar las descripciones clásicas de las paranoias.

El término "paranoia" dejó de utilizarse en la cuarta versión del *Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales* de la Asociación Americana de Psiquiatría (APA),

⁵⁸ " (...) la Paranoia no es única", escribía en su artículo "Las psicosis alucinatorias crónicas" (Gatan de Clérambault, 1923: 111).

conocido como DSM por su sigla en inglés. En estos manuales el malestar es definido en términos de “trastorno”.⁵⁹

Podría pensarse que varias de las descripciones clínicas clásicas de las paranoias quedarían englobadas por la categoría actual de **“trastorno delirante”**, que se caracteriza por una serie de criterios en el DSM IV. El primero es que se presenten una o más ideas delirantes con una duración de al menos un mes, y que no cumplan con los criterios para diagnosticar esquizofrenia. Es decir que no hay rareza ni deterioro significativo en el ámbito psicosocial, ni alucinaciones. Tampoco deben presentarse durante un trastorno afectivo concomitante al delirio, ni haber sido causadas por intoxicación⁶⁰ o por enfermedad médica. El diagnóstico puede ser precisado aún más, según los autores, agregando el tipo de delirio, según el contenido: erotómano, de grandeza, de celos, de persecución, somático, mixto o no especificado. Veremos cómo para los clásicos, el contenido del delirio no era considerado como un elemento de referencia, sino las características formales del delirio y su evolución típica.

Para estos Manuales, las ideas delirantes son el síntoma esencial del trastorno delirante y las consideran como “creencias erróneas que habitualmente implican una mala interpretación de las percepciones o las experiencias” (APA, 1994: 281). Aclaran además que es muy difícil para el clínico diferenciarlas de las ideas sostenidas con tenacidad, ya que esta diferencia depende del grado de convicción, a pesar de las evidencias contrarias. Una “idea sostenida con tenacidad” podría ser una idea religiosa; más aún, lo que se suele llamar el “fanatismo” religioso.

Podría ser necesario distinguir una idea tenaz de una idea delirante, por ejemplo, en algún peritaje judicial. En tal caso quizás sea útil volver a la definición clásica de Sérieux y Capgras sobre la interpretación delirante, en tanto en ella se destaca el detalle de la significación personal a la hora de formarse un juicio clínico sobre el carácter delirante de una idea. Este detalle se opone a lo grueso, lo grosero, de la clínica “actual”, al definir lo delirante como una idea sostenida con “tenacidad”, siendo que algo así podríamos encontrarlo por ejemplo en el caso Dora con sus ideas hipervalentes.⁶¹ En el apartado dedicado al delirio interpretativo reconstruiremos los criterios con los cuales Sérieux y Capgras proponen distinguir a las interpretaciones delirantes de las interpretaciones erróneas, por ejemplo.

Por otra parte, si bien el trastorno de ideas delirantes parecería englobar a varias de las presentaciones paranoicas que desmenuzaremos en los capítulos de esta parte, podemos agregar que lo referido por los clásicos en términos de carácter paranoico parece haber encontrado un lugar en los manuales en la categoría de **“trastorno paranoide de la personalidad”**. Un trastorno de la personalidad es en el DSM:

(...) un patrón permanente e inflexible de experiencia interna y de comportamiento que se aparta acusadamente de las expectativas de la cultura del sujeto, tiene

⁵⁹ Cf. parte II de este libro.

⁶⁰ Cf. parte dedicada a las psicosis tóxicas en este libro.

⁶¹ Véase un comentario al respecto en este libro, en la parte destinada a las características de los fenómenos elementales.

su inicio en la adolescencia o principio de la edad adulta, es estable a lo largo del tiempo y comporta malestar o perjuicios para el sujeto (APA, 1994: 645).

En función del diagnóstico multiaxial del DSM IV, los trastornos de la personalidad se ubican en el eje diagnóstico II, por lo que pueden diagnosticarse simultáneamente a otro trastorno del eje I, por ejemplo junto a una esquizofrenia o un trastorno delirante. Para diagnosticar un trastorno paranoide de la personalidad según el DSM IV deben cumplirse dos criterios. El criterio A define clínica y positivamente al trastorno como una desconfianza general, desde que comienza la edad adulta, que hace que se interpreten las intenciones de los demás como malintencionadas. También es un criterio de clasificación politético, dado que esta característica general se puede expresar a través de siete indicadores, de los cuales es necesario presentar al menos cuatro. Entre ellos se incluyen: sospechas infundadas de la malicia de los otros hacia ellos, preocupaciones constantes acerca de la fidelidad o la lealtad de sus allegados, reticencia marcada, actitud constante de vislumbrar significados ocultos y amenazantes en hechos nimios, rencores duraderos o dificultad para olvidar agravios sufridos, sensación de ser atacado por los otros y predisposición continua a contraatacar, sospechas injustificadas de infidelidad.

La nueva versión de la *Clasificación Diagnóstica y Estadística de los Trastornos Mentales*, DSM-V, publicada por primera vez en 2013 no mejora la suerte de la paranoia, sino que contribuye a su dilución definitiva. La perspectiva dimensional del diagnóstico sustituye al abordaje categorial (APA, 2013), que demostró generar una serie de inconvenientes como la multiplicación de los diagnósticos no especificados y las comorbilidades en exceso (Artigas-Pallarés, Paula-Pérez, 2015).⁶² Simultáneamente, los autores del DSM V sostienen que la realidad clínica ya no se aviene a las categorías, dado que se presenta una heterogeneidad sintomática en cada trastorno y una cantidad importante de síntomas que se comparten entre trastornos antes considerados como distintos (APA, 2013). La aplicación de este punto de vista impacta en la concepción del trastorno delirante, ya que a partir de entonces termina de borrarse su diferencia con la esquizofrenia para ser incluido en el espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos.

Como vemos, parece quedar poco de la paranoia en esta perspectiva, quizás sólo la magra referencia a "otros trastornos psicóticos".

Veremos a continuación cómo los psiquiatras clásicos -en una época en donde las subjetividades no estaban impregnadas por el efecto de los psicofármacos- se encargaron de precisar una forma clínica particular de psicosis que era necesario distinguir de la esquizofrenia, por la ausencia de deterioro y la conservación de la personalidad; pero también de la locura maníaco-depresiva, por no estar perturbada la afectividad, sino que los trastornos afectaban especialmente al juicio. Las paranoias desvelaron a aquellos psiquiatras que enfrentaron una forma de la locura caracterizada por su excesivo rigor lógico y no por el déficit. Hallaremos en el psicoanálisis renovado por Lacan a partir de su retorno a Freud algunas pistas para emitir un juicio, ahora sí, sobre la vigencia clínica de las paranoias.

⁶² Cf. parte II.

Referencias bibliográficas

- APA. (1980). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders: DSM III*. Washington: APA.
- APA. (1994). *Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales: DSM IV*. Barcelona: Masson.
- APA. (2014). *Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales: DSM-V*. Barcelona: Masson.
- Artigas-Pallarés J., Paula-Pérez, I. (2015). Asignaturas pendientes del DSM-5. *Rev Neurol*, 2015; 60 (Supl 1): S95-101.
- Barreda, R. (1995). Citado por Belmonte, A. (2004). *¡Mate Barreda!* Buenos Aires: Ediciones de la Orilla.
- Gatian de Clérambault, G. (1923). Las psicosis alucinatorias crónicas. En G.G. de Clérambault, *Automatismo Mental. Paranoia*. Buenos Aires: Polemos.
- Giannoni, M. (2012). Hasta que la muerte nos separe. Representación del asesinato de mujeres en la prensa argentina. En S. Barroso, M. Dovio, V. López Tessore, M. Giannoni (Comps.). *Mujeres en cuestión. Escrituras, ideologías y cuerpos*. Buenos Aires: Ed. Teseo, p. 207-243.
- Giberti, E. (2011). Femicidios en Argentina. Aportes y análisis de la sacralización popular de un femicidio serial: el caso Barreda. Recuperado de <http://evagiberti.com/femicidios-en-argentina-aportes-y-analisis-de-la-sacralizacion-popular-de-un-femicidio-serial-el-caso-barreda/>
- Lombardi, G., Kahanoff, D., Laje, M., Otero, T. (2015). Impasses del sentimiento inconsciente de culpa. Recuperado de <http://www.aacademica.org/>
- Martin, J. (2018). Antecedentes y conceptos del problema de las condiciones subjetivas en un femicidio múltiple: el estudio del caso Barreda en la perspectiva del psicoanálisis. *Anuario Temas en Psicología Volumen IV*. La Plata: EDULP. En prensa

CAPÍTULO 15

La paranoia clásica y sus críticas

Julia Martin, Nicolás Maugeri

y Analía Regairaz

Antecedentes

La progresión no lineal del devenir del conocimiento científico en el campo psiquiátrico, con sus diversos efectos tras la aparición del psicoanálisis, ha sido presentada en cantidad de trabajos reconocidos y con decisivo valor propedéutico.⁶³ En nuestro interés respecto de las paranoias hemos de retornar al legado de los clásicos, no sin destacar la influencia de los estudios historiográficos y el reconocimiento que el mismo Jacques Lacan hace del valor de la clínica psiquiátrica: “hay tipos de síntoma, hay una clínica. Sólo ocurre que esa clínica es anterior al discurso analítico” (Lacan, 1973: 583). Es aquí que introducimos lo esencial de la reducción operada por Kraepelin en su definición clásica de esta forma de estar-en-el-mundo, la paranoia. Esta definición pertenece a la sexta edición de su *Tratado*. Realizaremos un recorrido sucinto por los antecedentes de la misma y un ordenamiento de los debates ocasionados, incluyendo la revisión de Kraepelin sobre su definición clásica.

El nudo de la discusión sobre las paranoias⁶⁴ se consolida en la primera mitad del siglo XX por las derivas del denominado segundo momento de los paradigmas de la psiquiatría -el de la clínica de las enfermedades mentales-⁶⁵, y a partir de la aparición de la definición kraepeliniana de la sexta edición, en la que comienza a delimitarse este campo de perturbaciones. Desde esta definición que la acota, la paranoia conlleva controversias en lo que atañe a su causa, pero también a los alcances de la categoría: antes de la consolidación del paradigma de la entidad clínico-evolutiva, hacía tiempo que en Alemania se diferenciaban los trastornos de los afectos de los de la inteligencia, primer germen de posteriores discusiones relevantes sobre el tema: afecto vs. razón.

"Paranoia" es una palabra proveniente del griego, utilizada por autores de la antigüedad con el significado de locura o perturbación de la razón, entre ellos Eurípides en el siglo V a.c., luego Aristófanes, Platón, Aristóteles e Hipócrates, quien la asimiló al delirio. En su etimología, *nûs* o *nóus* literalmente ‘mente’ se añade a *para-* ‘fuera de’ o ‘más allá de’-, refiriendo a la idea

⁶³ Algunos de ellos se trabajan en la parte I y II de este libro.

⁶⁴ Para los interesados en profundizar en este tema recomendamos la obra colectiva: Napolitano, G. & cols. (2002). *El debate sobre la paranoia en la primera mitad del siglo XX*. La Plata: De la Campana.

⁶⁵ Cf. parte II.

de locura o desvarío (Coromines, 1961: 413; Gómez de Silva, 1985: 518). Respecto de su aparición en el campo semántico de la psiquiatría, su uso inicial para hablar de trastornos de la razón se sitúa en Alemania. Se reconocen por entonces en la escuela alemana dos grandes posturas coexistentes sobre la cuestión de la clínica mental: los denominados "psíquicos", que consideraban que las enfermedades mentales eran causadas por una afección del alma, con una connotación moral ligada a la idea de pecado -hipótesis que relacionaba la locura con la divinidad-; y los "somatistas", cuya tesis ligaba las enfermedades mentales a una localización corpórea. Los primeros estaban vinculados generalmente a la academia, los segundos a los directorios de los hospicios.

J. C. Heinroth, entre "los psíquicos", supo reconocer tempranamente una exaltación de la facultad representativa para la que introduce el término "paranoia" en 1818 (Lacan, 1932: 21), y que opone a los trastornos relativos a lo afectivo. Varias fuentes convergen en que se trataría del primer autor que usa la expresión "paranoia" como sinónimo del término alemán *Verrücktheit*. Este último vocablo, traducido usualmente como *locura* desarrollada en el ámbito de la razón o *delirio*, ya había sido empleado por Kant para hablar de la pérdida del sentido común (Lester, 2017: 493). Luego, el término "paranoia" es utilizado en un sentido específicamente psiquiátrico por Kahlbaum en 1863, desplazando al vocablo *Verrücktheit* (Kraepelin, 1915: 121). En definitiva, aquello designado como paranoia queda tempranamente vinculado con los trastornos del juicio, del raciocinio, y de las representaciones.

En la vereda opuesta, y en una posición intermedia, entre una clínica de la alienación mental y una clínica de las enfermedades mentales,⁶⁶ Griesinger -considerado somatista- plantea el modelo de la psicosis única entendida como una enfermedad del cerebro que comienza con un trastorno en la esfera afectiva sobre el que luego sobrevendría un delirio sistematizado ligado al juicio, que culminaría en demencia. Combina de este modo la gran división inicial de Heinroth que oponía lo afectivo a la razón. En 1845, Griesinger llama "*Verrücktheit*" al trastorno crónico de tipo secundario a un trastorno afectivo inicial: la psicosis única [*Einheitspsychose*] debutaría con melancolía [*Schermut*] y/o manía [*Tollheit*],⁶⁷ continuaría con el delirio paranoico [*Verrücktheit*] para finalizar con demencia [*Blödsinn*]. Aquí entonces, la paranoia quedaría reservada a ese momento intermedio en el curso de la psicosis única, crónica, sucediendo al trastorno afectivo.

Griesinger aísla otra forma a la que llamará "*Wahnsinn*", que correspondería a una locura delirante exaltada, episódica, en la que el distingo entre lo primario y lo secundario deja de tener relevancia por lo explosivo del cuadro. Esta última se caracteriza por ser aguda. Westphal sugiere también la posibilidad de un curso agudo de la paranoia (Kraepelin, 1899: 103). Vemos esbozado un segundo y tercer problema de debate: crónico vs. agudo, primario vs. secundario.

El idioma alemán provee dos términos para referirse al delirio: *Verrücktheit*, ligado a las presentaciones crónicas, y *Wahnsinn*, para los episodios delirantes agudos. La escuela francesa llama a estos últimos "*bouffée*" delirante, justamente para subrayar el carácter explosivo,

⁶⁶ Cf. parte II.

⁶⁷ Cf. parte V.

súbito de la aparición de estos delirios, como si se tratara de una bocanada. Es el primer término, *Verrücktheit*, el que clásicamente se ha asociado a la paranoia en tanto delirio sistematizado crónico.

En 1865, Snell, junto con el ya mencionado Westphal y con Sander, postula la existencia de una *Verrücktheit* primaria. Para Snell, no todos los delirios crónicos se inician con un trastorno afectivo, por ende, no todo delirio es secundario. Describe un tipo de delirio que comienza sin ningún trastorno afectivo, es primario y convive con las alucinaciones, esa es la *Verrücktheit* primaria. En 1867, Griesinger acuerda en que la paranoia no se somete al curso de la psicosis única, sino que es independiente en el sentido de un inicio sin trastornos afectivos, como había indicado Snell previamente.

Krafft-Ebing, por su parte, rechaza todo tipo de forma aguda de paranoia. Para él, la paranoia sólo abarca las formas crónicas, producto de una degeneración psíquica: se trata de ideas delirantes primarias, fijas y sistemáticas, que provocan la transformación de la persona en otra. Una anomalía de carácter da lugar, entonces, a una constitución paranoica. Reitera el uso del término *Wahnsinn* para los delirios agudos. Se retoma por tanto el problema de lo crónico vs. lo agudo, y se suma el cuarto y quinto eje de debates a la postre: constitución vs. psicogénesis. La paranoia comienza a delimitarse en torno a la presencia de una ideación delirante sistematizada y duradera, no meramente episódica, cuya consistencia se asemeja a una forma de la personalidad. Encontramos allí los primeros indicios que vinculan a la paranoia con una forma de ser, constitucional, endógena y no adquirida.

Kahlbaum en 1868 intenta ordenar el caos nosográfico que comienza a producirse, este incipiente “babelismo” en torno a la paranoia (Álvarez, 1985). Reserva el término “paranoia” para aquellos delirios crónicos más o menos sistematizados, cuyo trastorno es puramente intelectual y donde los afectos jugarían un papel meramente secundario.

También Neisser hace aportes clínicos de relevancia que serán retomados por Lacan en su seminario sobre las psicosis. Circunscribe un detalle clínico de suma importancia: la *krankhafter Eigenbeziehung*, traducida al francés por Sérieux y Capgras como significación personal.⁶⁸ En 1891 se interroga por la sintomatología de la paranoia, y del conjunto de esa sintomatología destaca a la significación personal como patognomónica:

Este proceso mental defectuoso se manifiesta en la manera de interpretar de los enfermos, al margen de las emociones y sin saberlo ni quererlo, las representaciones son ofrecidas a su conciencia como algo especialmente relacionado con su propia persona. Que esto ocurre realmente y sin excepciones, aunque no constantemente con la vivacidad indicada, nos lo enseña la observación clínica (Neisser, 1891: 87).

La **significación personal o autorreferencia mórbida** es un modo patológico de interpretar, independiente de las emociones y de un querer malintencionado del enfermo. Los pensa-

⁶⁸ Quinet (2016) hace una interesante crítica a esta traducción, y propone la expresión “autorreferencia mórbida” para este término de Neisser (p. 125).

mientos erróneos que configuran la trama delirante tienen el fin de tramitar este fenómeno inicial de significación personal, que funciona automáticamente. Aquí el delirio vuelve a aparecer secundariamente.

Los aportes de estos autores conformaron el prelude de aquello que se coincide en designar como la definición clásica de la paranoia propuesta por Kraepelin en la sexta edición de su *Tratado* sobre las enfermedades mentales, de 1899. Este autor, siguiendo el intento de Kahlbaum, toma a su cargo la ardua tarea de ensayar la estabilización conceptual de una categoría laxa, que en ese momento se revela difusamente definida: en cuanto a su aparición (primaria vs. secundaria), su causa (constitucional o adquirida), su mecanismo (interpretación y/o alucinaciones), su duración (aguda, crónica) y la temática del delirio.

Una prueba del carácter difuso de la categoría en sus albores es que cerca de un 80 % de los enfermos asilados en esa época eran diagnosticados como paranoicos (Lacan, 1932: 21), tal como señalaron el mismo Kraepelin y Bouman. Lacan aclara en el seminario III que en ese momento el término paranoia era utilizado casi como un sinónimo de locura: "Todo lo que llamamos psicosis o locura era paranoia" (Lacan, 1955-1956: 13). Esta proliferación inicial sufre un paulatino proceso de reducción hasta su casi desaparición en la actualidad. El paso inicial en la restricción de este tipo clínico lo da Kraepelin con su clásica definición.

La definición clásica de la paranoia según Kraepelin (1899-1913)

Como puede desprenderse de las diversas ediciones de su *Tratado*, Kraepelin es un clínico que considera al padecimiento mental como una verdadera enfermedad. En la primera edición de 1894, clasifica a las enfermedades mentales de acuerdo a un criterio diacrónico rudimentario, que le permite dividir las en estados agudos, crónicos, periódicos y deteriorativos. Utiliza un criterio clínico evolutivo, pero todavía se vale de un criterio sindrómico grosero. Su clasificación está atravesada por el análisis psicológico de las facultades, influenciado por el asociacionismo de Wundt. Luego, la mirada diacrónica se perfecciona, al hacer hincapié en el estadio terminal, que se podría predecir desde el principio por pequeños signos.⁶⁹ En la sexta edición del *Tratado*, la clasificación de las enfermedades alcanza trece categorías (Bercherie, 1980: 111), divididas en dos grandes grupos según el predominio causal:

- 1) adquiridas o exógenas: un factor exógeno afectaría al cerebro. Pueden ser factores infecciosos, metabólicos, tóxicos o lesionales. Se trata de las primeras ocho clases de enfermedades.⁷⁰
- 2) endógenas: las causas serían degenerativas, es decir, relativas a una tara constitucional del cerebro, o constitucionales. Son enfermedades congénitas, de nacimiento, connaturales al sujeto, de causas internas.

⁶⁹ Un análisis detallado sobre los criterios de las clasificaciones en Kraepelin puede encontrarse en la parte II de este libro.

⁷⁰ Kraepelin hace una salvedad con respecto a la clase 5 que incluye a la demencia precoz, cuya posición sería intermedia respecto de la causa, entre factores lesionales y autotóxicos (Cf. parte VI).

Ambos tipos de causas remiten a una referencia orgánica, se trate de un factor exógeno al cerebro, o endógeno en lo que respecta a su funcionamiento. El origen está fijado en el cuerpo, en lo biológico. Kraepelin adscribe al paralelismo psicofísico. La causa orgánica se traduciría clínicamente en el plano anímico de modo directo: el efecto psíquico depende de la causa orgánica.

Tres entidades importantes se extraen de este *Tratado*: la demencia precoz, la locura maniacodepresiva y la paranoia. Nos interesa retomarlas porque se trata de una distinción que sigue resultando operativa en la clínica actual.

En su "Lección sobre paranoia", Kraepelin diferencia nítidamente a la paranoia de las dos primeras entidades, la demencia precoz y la locura maniacodepresiva. La define así:

(...) un grupo de casos donde un sistema delirante inquebrantable y duradero, claramente reconocible desde el principio, se desarrolla gradualmente, a la vez que se conserva por completo la presencia del entendimiento y el orden del curso del pensamiento. Es para estas formas que quiero reservar el nombre de paranoia (Kraepelin, 1899: 106).

La paranoia, clasificada como **enfermedad endógena o constitucional**, de causas internas, queda definida también en la octava edición del *Tratado*, publicada entre 1909 y 1913, por esos mismos rasgos:

(...) sistema delirante, duradero, inamovible, de desarrollo insidioso y de aparición por causas internas, acompañado por un perfecto mantenimiento de la claridad y orden de pensamiento, voluntad y proceder. Al mismo tiempo se suele producir una transformación profunda de la concepción total de la vida y es a esa "dislocación" [*Verrückung*] del criterio respecto al medio ambiente, que se desearía caracterizar con el nombre de "paranoia" [*Verrücktheit*] (Kraepelin, 1913: 67-68).

A diferencia de la demencia precoz, en la paranoia no están afectadas fundamentalmente ni la voluntad, ni la afectividad, ni el curso del pensamiento. Además, no hay terminación demencial, ni fuerte presencia del elemento alucinatorio que Kraepelin excluye de su definición clásica.

Asistimos en esta definición, punto por punto, al modelo de la entidad clínico-evolutiva por excelencia, en tanto se evidencian en la delimitación categorial los criterios:

- **Clínico-evolutivo y estadio terminal:** Se detiene en describir el curso de la enfermedad. El modo de inicio es insidioso, es decir, solapado, poco evidente al comienzo y progresivo. El sistema delirante que se desarrolla se encuentra en continuidad con la personalidad; su evolución es continua; su terminación no es demencial, pero sí incurable en lo que respecta al sistema delirante.
- **Psicopatológico descriptivo:** La descripción clínica del síntoma cardinal está en estrecha relación con la psicología de las facultades. Se trata en el caso de la paranoia de un sistema delirante inquebrantable que no impide conservar el entendimiento y el

orden del curso del pensamiento. Es decir, no evoluciona al déficit de dichas facultades, y no hay, como en otras enfermedades, la constatación de alucinaciones. Existe un trabajo de elaboración lento, gradual, progresivo, que apunta a la coherencia de estas ideas delirantes, a eliminar contradicciones internas, encontrar motivos, efectos, y se halla una convicción, por lo que es imposible de quebrantar, es inalterable, incorregible. El trastorno afecta principalmente al juicio.

La delimitación de estos dos criterios es crucial para distinguir lo propiamente paranoico de lo paranoide. En 1899 Kraepelin se ocupa de clasificar una **forma paranoide de la demencia praecox** con dos variantes, que no se incluyen en la paranoia: la demencia paranoide, un tipo de casos cuyo elemento delirante no posee una sistematización acabada y que, a diferencia de los verdaderos paranoicos, concluyen en demencia; y las paranoias alucinatorias o delirios sistematizados fantásticos, que también tienen una terminación demencial con presencia de mecanismo alucinatorio y temática fantástica. En estas variedades paranoides de la demencia precoz, se halla una perturbación primaria de la afectividad, del razonamiento y de la voluntad, como en todo el conjunto de esta clase: trastornos ausentes en la paranoia propuesta en la sexta edición.⁷¹

La verdadera paranoia kraepeliniana reposa en dos **mecanismos fundamentales**: el delirio de referencia o de significación personal -el sujeto interpreta que distintas situaciones de la vida cotidiana están en relación directa con él-; y las ilusiones de la memoria o confabulaciones, en las que se trata de falsos recuerdos, o recuerdos de un acontecimiento realmente vivido por el sujeto, pero que es interpretado de un modo particular, autorreferencialmente. El delirio puede adquirir entonces un carácter retrospectivo. La interpretación delirante⁷² se explica por una concepción falseada del mundo, que nace en una construcción morbosa de los sucesos y las cosas de la vida, con la cual el enfermo fabrica sus percepciones. Esta construcción va conformando un sistema de carácter centrípeto, todo está dirigido al enfermo y le concierne. Primero surgen sospechas, que luego se van gradualmente convirtiendo en certezas, en convicciones invencibles que no ceden al razonamiento. De este trabajo se derivan los diferentes temas: de persecución, de celos, de grandeza, de erotomanía y la forma especial del delirio de querulancia -los perseguidos-perseguidores que ya habían sido descriptos en la escuela francesa por Lasègue, quienes reivindicar un daño o perjuicio sufrido-.

Kraepelin enfatiza cómo estos enfermos pueden pasar por años desapercibidos, en tanto logran ocultar muy bien los motivos de su conducta, de manera tal que no se pueden discernir acciones mórbidas en su vida cotidiana, ni se evidencia trastorno alguno por largo tiempo. Señala que muchas veces los indicios son sólo detalles que pueden revelar el camino por el que marcha la construcción delirante: una vestimenta extraña, un gusto demasiado entusiasta por empeños religiosos o políticos, en fin, cuestiones que el sentido común tiende a atribuir a personalidades fuertes, extravagantes o a defectos del carácter (Kraepelin, 1899: 115).

⁷¹ Un desarrollo detallado acerca de las formas paranoides de la demencia precoz se encuentra en la parte destinada a las esquizofrenias en este libro.

⁷² Cf. con la parte III sobre los fenómenos elementales.

Así, este autor describe en la sexta edición varios casos que habían pasado inadvertidos para su entorno, hasta que acontece bruscamente un acto agresivo o extremadamente bizarro: tal es el caso de un paciente quien, para evitar persecuciones e interrogatorios continuos, cambia de trabajo con vanos pretextos o emprende un largo viaje. Esto ayuda un tiempo, pero pronto las alusiones y la sensación de ser vigilado lo invaden hasta creer que su situación es peor que la de una persona bajo orden de arresto. Intenta entonces por medio de avisos en diarios, estigmatizar a sus enemigos. Otro ejemplo es el de un joven estudiante que de un momento a otro hiere seriamente a su familia cuando el extraño sabor en la sopa le indicó que se trataba de un intento de envenenamiento. Este pequeño detalle reveló la ideación oculta: lo querían envenenar porque él era descendiente de Napoleón.

En estas descripciones, Kraepelin reitera que los paranoicos pueden no ser reconocidos como enfermos mentales: el sistema delirante que lentamente se va construyendo con mucha consistencia queda preservado del resto del funcionamiento vital del sujeto, es decir, coexiste el delirio con la lucidez (Kraepelin, 1899: 122). Lacan (1931) dice de estos pacientes "su portero los aprecia" (p.9), al mismo tiempo que destaca que el delirio interpretativo paranoico es un delirio de la calle, la "precipitación de detalles significativos" se produce sobre todo al interpretar el accionar de los demás (p. 10).

Kraepelin advierte y subraya con énfasis la consecuente dificultad inicial del diagnóstico de paranoia tal como él la define, debido a este carácter discreto de su desarrollo insidioso. Señala asimismo que los casos definidos de esta manera corresponden a un número restringido, "ni siquiera alcanza al 1 % de los casos admitidos" (Kraepelin, 1899: 118). Es decir que esta precisión de Kraepelin sobre esta categoría clínica permite pasar de un 80% de diagnósticos de una paranoia evidentemente no muy específica a un 1% de casos de paranoicos delimitados en forma muy clara. De ahí que podemos decir que esta definición clásica implicó una primera reducción drástica de la paranoia.

La paranoia de Kraepelin presenta dos variedades o **formas clínicas** en 1899: el delirio de interpretación y el delirio de querulancia, este último ya aislado bajo el nombre de los perseguidos-perseguidores de Lasègue, futuro delirio de reivindicación. El caso del perseguido por la Bulldog, que presenta en sus lecciones, es un claro ejemplo de delirio interpretativo. Mientras que el caso del maestro sastre corresponde a la presentación del delirio de querulancia (Kraepelin, 1900: 147-155).

La reducción de la paranoia en razón de criterios precisamente delimitados —que Bercherie (1981) adjudica a una tendencia de la escuela alemana: "tentaciones a la síntesis y a la estrechez" (p.115)- será ocasión de múltiples críticas. Recuperaremos sucintamente a continuación los principales aportes de la escuela suizo-alemana y francesa, así como el eco que Kraepelin se hace de las críticas a su categoría, que lo lleva a una revisión de la paranoia en la octava edición del *Tratado* y que termina por restringir aún más a la paranoia, reduciéndola únicamente a los delirios interpretativos.

Críticas de la escuela suizo-alemana y de la escuela francesa

Como hemos adelantado, la definición clásica de la paranoia se ve cuestionada punto por punto, abriéndose una línea de investigación fructífera, sobre todo en lo que atañe a las formas agudas, abortivas o curables, y las alucinatorias (Álvarez, 1997).

Los cuestionamientos a la paranoia kraepeliniana giran fundamentalmente en torno a lo insidioso de su desarrollo y a su cronicidad, es decir, se discuten las variedades en su terminación, sus posibilidades de cura y la exclusión de las alucinaciones para su diagnóstico.

En la perspectiva de la corriente psicodinamista,⁷³ **Bleuler** cuestiona la incurabilidad y el desarrollo insidioso y gradual del sistema delirante, al resituar el lugar del afecto y recuperar así la vieja discusión acerca del carácter primario o secundario del delirio.⁷⁴ Sus contribuciones fundamentales giran en torno a la suposición de un trastorno primario afectivo en la base de la paranoia. La paranoia sería por tanto una reacción delirante basada en una acción catatímica⁷⁵ de los afectos, cuya finalidad consiste en rechazar la realidad insufrible, imputando la culpabilidad y responsabilidad a otros. También admite formas agudas. Sin embargo, no deja de recuperar aspectos esenciales de la definición clásica kraepeliniana en lo que respecta al delirio como síntoma cardinal.

Como veremos luego, Kraepelin termina excluyendo a los querulantes de la paranoia en la octava edición, en parte como respuesta a esta crítica, dado que en el caso de los delirios de querulancia existe un hecho real que implicó un perjuicio: es decir, se constata en la causación la reacción afectiva ante una vivencia. Bleuler, sin embargo, sigue más bien fiel a las dos variedades clínicas de la paranoia en la sexta edición: delirio interpretativo y delirio de querulancia. No obstante, los desarrollos de Bleuler comienzan a cuestionar que la paranoia constituya una afección únicamente del juicio y del intelecto, para incorporar el valor causal de los afectos.

Sin dudas, esta tesis del valor causal de la afectividad introduce una enorme complejización a nivel de los factores que se consideran causales y que excede ampliamente a la tesis etiológica de Kraepelin, quien sostenía el paralelismo psicofísico propio del paradigma de las enfermedades mentales. En adelante, las nuevas propuestas no retroceden con respecto a esta pluralización de factores causales propia del tercer paradigma.

Por ejemplo, en 1918 **Kretschmer** introduce el delirio de relación sensitivo, al proponer que la paranoia es una reacción con tres determinantes: el carácter (particularmente sensitivo, susceptible, vulnerable, débil); la vivencia (experiencia vivida que le revela al sujeto su insuficiencia); el medio social (constelaciones relacionales). La evolución favorable o benigna confirmaría así la psicogenia de la enfermedad que tiene su origen en la acción acumulativa de vivencias típicas sobre una disposición de carácter particular y un medio social característico. Nos detendremos más adelante en los aportes de este autor. La cuestión al respecto de la psicogénesis es retomada por Lacan en su

⁷³ Cf. parte II para mayores precisiones sobre las principales características de esta corriente.

⁷⁴ Este debate de retoma en la parte III de este libro sobre los fenómenos elementales.

⁷⁵ Catatimia: f. (Psiquiatría/Psicol.) Deformación de la realidad por influencia de la afectividad en estados emocionales intensos (Universidad de Salamanca, 2018).

tesis sobre el caso Aimée (1932), en la que releva los aportes de Kretschmer y de Jaspers, pero luego los critica en su seminario sobre la psicosis, ubicándose para ese entonces en las antípodas de la comprensión genética respecto del fenómeno psicótico.

Respecto de la cronicidad, Friedmann en 1905 introduce las **formas benignas de la paranoia**. Se trata de paranoias que tienen un desarrollo breve y luego culminan. Son formas que encuentran sus antecedentes en la distinción de Griesinger respecto al *Wahnsinn*, o en Westphal con la propuesta de la paranoia de curso agudo.

Pero quizás el autor más resonante sobre el tema sea Gaupp, con su planteo de la **paranoia abortiva**, que subyace a su análisis del resonado caso Wagner (Gaupp, 1914; Gaupp, 1920). Wagner era un maestro de pueblo que, preso de un delirio de referencia ligado a delitos sexuales que habría cometido, asesinó durante la noche a su mujer y a sus dos hijos, desplazándose luego a Mühlhausen donde mató a otras nueve personas e hirió de gravedad a una veintena. Gaupp destacó que se trataba de un hombre culto y dedicado a la enseñanza, que cometió sus crímenes después de planearlos y prepararlos cuidadosamente.

Tras el sobreseimiento de los cargos que pesaban sobre él con motivo de declararlo enfermo mental, Gaupp advierte: "(...) va siendo hora de poner en primer plano la importancia científica de todo el caso" (Gaupp, 1914: 25). Este autor aclara que Wagner no aceptó su condición de enfermo: "El propio Wagner niega ser enfermo mental o haberlo sido alguna vez. Se presenta todo el tiempo como una persona responsable y que actúa en pleno uso de sus facultades mentales" (Gaupp, 1914: 218)⁷⁶ y Gaupp parece acompañarlo en esta apreciación: "En muchos ámbitos de la vida había conservado un discernimiento normal (...) su delirio no llegó a ser un delirio de persecución generalizado (...) En el hospital, por ejemplo, se liberó completamente de él" (Gaupp, 1914: 220). Sin embargo, haciendo tambalear la categoría abortiva que él mismo propone, añade: "(...) aunque este mecanismo reposara de a ratos, el antiguo delirio, generado por tormentas psíquicas muy serias, seguía estando ahí" (Gaupp, 1914: 220). Gaupp logra colegir que el pasaje al acto tiene una función: el hombre vuelve a sentirse puro respecto de su culpabilidad en torno a la sexualidad. De este modo, el autor transmite una interpretación de la paranoia que defiende el carácter psicológico, dinámico, comprensible y reversible de la misma, aunque no deja de indicar estas contradicciones entre lo que desaparece y lo que resta del delirio luego del pasaje al acto criminal.

Puede observarse hasta aquí cómo esta clínica de paranoias abortivas parece cuestionar la restringida clase de Kraepelin en su sexta edición. Debemos preguntarnos si por ello la invalida.

Por su parte, los autores franceses, también contribuyeron a los debates transcurridos en el siglo XX en el campo de las paranoias, en torno a aspectos tales como la ubicación de los delirios frente a la esquizofrenia, el lugar en la nosografía de los delirios alucinatorios crónicos no demenciales, el papel de la biografía y la personalidad del paciente en la génesis del delirio, la presencia simultánea de otros síntomas y conductas patológicas, entre otros. Destacamos que,

⁷⁶ Otro caso que pone de manifiesto este mismo punto en común es el de Althusser, quien al ser declarado inimputable por el homicidio de su esposa, decide escribir un testimonio autobiográfico justificando su responsabilidad en ese acto. Para mayor amplitud sobre el tema revisar el libro de Althusser, L. (1993). *El porvenir es largo. Los hechos*. Buenos Aires: Ed. Destino.

a diferencia de las contribuciones que han realizado los autores suizo-alemanes, la escuela francesa se ocupa en menor medida de los temas y de la evolución del delirio, interesándose más bien en el mecanismo mental que lo organiza, donde se distingue fundamentalmente el mecanismo interpretativo del pasional.⁷⁷

Ségla, por ejemplo, discute la posición kraepeliniana de excluir de la paranoia a las formas agudas o demenciales y subsumirlas en las formas paranoides de la demencia precoz. Para él la paranoia incluiría no sólo los delirios sistematizados, sino también las formas agudas y alucinatorias (Ségla, 1900). Se evidencia la creciente preocupación por encontrar el denominador común de formas que aun siendo tan variadas, parecen resonar en un punto fundamental que poco a poco tiende a circunscribirse.

Sérieux y Capgras avanzan en este punto cuando en 1909 proponen separar el delirio interpretativo en sus dos vertientes -megalomaniaca o persecutoria-, del delirio reivindicativo -egocéntrico o altruista-. El mecanismo interpretativo es patológico en la medida en que el sujeto considere que los datos de la realidad están dirigidos hacia él -ya hemos mencionado que Neisser llama a este fenómeno "significación personal"-.

La importancia de la afectividad en la paranoia gana terreno también de la mano de Gatian de Clérambault, maestro de Lacan, quien distingue el mecanismo de los delirios pasionales del de los interpretativos. Lo llama "elemento generador" y es un núcleo ideoafectivo que queda por fuera de lo que es el automatismo mental y el síndrome de pasividad propio de las psicosis alucinatorias crónicas.⁷⁸ Llama "postulado" a este núcleo-ideoafectivo y precisa que en el delirio erotomaniaco cobra la siguiente forma: "el otro me ama". En la relación entre el yo y el mundo, es el otro el que avanza sobre el sujeto y toma la iniciativa de amarlo. Se trata de delirios en sector, dado que no es la interpretación la que opera sobre los datos primarios al modo de una red que se expande, sino que el elemento interpretativo queda coagulado en el axioma del postulado, cuyo envión hipomaniaco deja al sujeto mucho más cercano del pasaje al acto.

La tesis de doctorado de Lacan de 1932 merece un párrafo aparte entre las críticas. Allí la psicogénesis jasperiana ocupa un lugar central que lo lleva a postular la categoría de "**paranoia de autopunición**". Si bien comienza con la idea de apoyarse en la noción de proceso, termina reconociendo en la psicosis de *Aimée*, la paciente de su estudio de caso, la incidencia de la noción de reacción. Para ese entonces ya había separado a la personalidad de la constitución, de la cual fue siempre muy crítico. Es en este trabajo donde ensaya el primer puente con el psicoanálisis, reconociendo la influencia del artículo de Guiraud sobre los crímenes inmotivados, al analizar el lugar de la culpabilidad en el desarrollo del delirio del caso tratado: *Aimée*, movilizada por el delirio, agrede a una famosa actriz. En ocasión de su encierro, rectifica la idea delirante que la motivó al acto, estando ésta enmarcada en los márgenes de lo comprensible. Por lo tanto, el cuadro paranoico de *Aimée* parece ceder con el pasaje al acto y la internación. Posteriormente, Lacan se encarga de criticar su propia tesis en lo que respecta a la psicogénesis, como veremos más adelante.

⁷⁷ Es importante señalar el uso médico que se hace en psiquiatría del término "mecanismo", al que se refieren estos autores. No se corresponde con la propuesta de Freud sobre los mecanismos del inconsciente.

⁷⁸ Cf. parte III.

En suma, constatamos que no sólo la escuela suizo-alemana cuestiona los principales puntos de la definición clásica de paranoia, sino que los hallazgos de los franceses ponen en jaque sus principales criterios. Son puestos en cuestión la continuidad y el desarrollo insidioso, proponiéndose en cambio el carácter rupturista de su aparición o incluso de su desaparición (paranoias abortivas o benignas). Se cuestiona el origen en causas internas, para subrayar el papel de la reacción a situaciones vitales y el rol de la afectividad. Por último, aparece el asunto de los delirios sistematizados crónicos alucinatorios.

Kraepelin parece tomar nota de la necesidad de revisión de los estrictos límites de su categoría, e incluye numerosas transformaciones al respecto en la octava edición de su *Tratado*: termina de restringir a la paranoia al delirio de interpretación, extrae de ese campo a los delirios querulantes, y crea el grupo de las parafrenias para dar lugar en la clasificación a las psicosis alucinatorias crónicas que no evolucionan a una terminación demencial.

El estallido de la noción clásica de paranoia

Kraepelin hace un intento por incluir todos estos aportes críticos en su clasificación de la octava edición, desarrollada entre 1909 y 1913. Incorpora las contribuciones de los psicodinamistas -y por lo tanto, la noción de reacción- e incluye en las enfermedades psicógenas a las llamadas "psicosis de relación" o locura de dos [*folie à deux*] de los franceses,⁷⁹ el delirio de persecución de los sordos y las psicosis de destino, entre las que considera a las psicosis de los prisioneros y al delirio de querulancia, que queda desde entonces por fuera de la paranoia. Se trata aquí de un reagrupamiento de una serie de afecciones ligadas a circunstancias exógenas, que reposan sobre predisposiciones psicopáticas degenerativas.

La concepción de la paranoia en Kraepelin se ve notoriamente influida por el análisis psicopatológico de Bleuler, al insistir en las lagunas del desarrollo intelectual y en la hipertrofia de un sentimiento de sí. Pero clínicamente se inspira en Sérieux y Capgras al separar a la paranoia, ahora limitada al delirio de interpretación, de los querulantes, cuyo delirio como hemos dicho se organiza en sector, con un curso más remitente que crónico. Aun así, Kraepelin insiste en que este desplazamiento tiene solamente una significación secundaria, en tanto lo que diferenciaría al delirio de querulancia de la paranoia se juega en las relaciones entre lo que puede adjudicarse a factores externos, el elemento psicógeno y lo constitucional.

Kraepelin admite también la existencia de las paranoias benignas, abortivas, "(...) o más bien le parece que una serie continua de hechos clínicos enlaza los grandes desarrollos paranoicos, pasando por esas formas frustras, de las personalidades paranoides que presentan de modo permanente el germen de los delirios típicos" (Bercherie, 1981: 172).

⁷⁹ Para más ampliación ver el trabajo de Julieta De Battista. (2006). Folie à deux- folie simultanée: el problema de la transmisión de la locura y el lazo social en la psicosis. *Memorias de las XIX Jornadas de residentes de Psicología y Psiquiatría de la Provincia de Buenos Aires. VI Jornadas de residentes de Salud Mental de la provincia de Buenos Aires "Modalidades de la urgencia"*. Volumen 1: 407-414.

Otra gran modificación de su octava edición es la separación de las **parafrenias** del grupo de la demencia precoz, como una clase diferenciada, que responde sobre todo a la polémica planteada por los psiquiatras franceses sobre la inclusión de todos los delirios crónicos alucinatorios en la demencia precoz.⁸⁰ En la parafrenia y sus variedades quedan patentizados los problemas de excluir la posibilidad del fenómeno alucinatorio de la paranoia. La variedad que llama "parafrenia confabulante" recuerda a las paranoias regidas por las ilusiones de la memoria más que por el delirio de referencia. El grupo parafrénico queda constituido por tres subgrupos: parafrenia sistemática -heredera del delirio crónico de Magnan-; el segundo está constituido por formas puras, expansivas y confabulantes, que constituye una transición hacia las formas paranoicas puras; el tercero, antigua demencia paranoide, linda con la *dementia praecox*. Pero el criterio que las unifica es la extensa conservación de la personalidad, la débil lesión volitiva y afectiva, junto con un delirio rico y paranoide. Aunque construida sobre un mismo eje que sería el delirio crónico, la parafrenia no se corresponde exactamente con la psicosis alucinatoria crónica francesa. El borde con la paranoia es por tanto difuso, excepto por la presencia de alucinaciones.

Vemos entonces que el intento de Kraepelin por complejizar el campo de su nosografía jaquea su inicial contribución al campo de la paranoia. No nos llama la atención entonces que Lacan proponga en su seminario sobre las psicosis: "Esta definición, fruto de la pluma de un clínico eminente tiene algo llamativo, y es que contradice punto por punto todos los datos de la clínica. Nada en ella es cierto" (Lacan, 1955-56: 31),⁸¹ al cuestionar sobre todo el planteo continuista del "desarrollo insidioso". Lacan aquí es contundente en que siempre hay ruptura. Sin embargo, creemos que hay una cierta moderación de la crítica cuando avanzando en la escritura y reconociendo las diferencias entre el delirio de interpretación y el delirio pasional, agrega: "¿Quiere decir que hay que dispersar los tipos clínicos, llegar a cierta pulverización? No lo pienso. El problema que se plantea afecta el cuadro de la paranoia en su conjunto" (Lacan, 1955-56: 32). Leemos allí entonces, nuevamente, que se trata de situar variedades de la paranoia, considerando a la kraepeliniana como una variante, entre otras, de una forma de padecer o estar-en-el-mundo que se distinguiría por algunas cuestiones nodales. Por cierto, es importante recordar que una de las últimas definiciones lacanianas de la paranoia vuelve a resaltar la cuestión de la continuidad, esta vez en términos de la continuidad indiferenciada entre los tres registros. Retomamos este punto en el apartado destinado a las conclusiones.

Algunos autores han sugerido que lo que escogemos denominar como "el síntoma Kraepelin" no es más que un indicio de la puesta en crisis del paradigma mismo de las enfermedades mentales (Álvarez, 2013), pero no por ello debemos perder de vista las exquisitas descripciones que los grandes clínicos han sabido realizar de este tipo particular de mal-estar en el mundo. En todo caso, queda claro que "lo paranoico" no se presenta de una sola manera; cabría designar con precisión qué unificaría ese campo que parece desperdigarse en el encuentro con la diversidad clínica.

⁸⁰ Cf. parte VI.

⁸¹ Para una revisión de la crítica completa a la definición kraepeliniana, remitirse a las páginas 31-32 del Seminario III de Lacan (1955-56).

Un joven Lacan, aún inscripto en el campo de la psiquiatría y antes de culminar la tesis doctoral de 1932 anteriormente referenciada, ensayó un ordenamiento de las variedades de la paranoia con precisión, en un texto denominado "Estructura de las psicosis paranoicas" (Lacan, 1931). Nos interesa recobrar esta categorización en tanto resulta organizadora respecto de la complejidad de las variadas formas de presentación de la paranoia. De este modo Lacan (1931) consigna tres tipos de psicosis paranoicas (p. 6):

- el delirio de interpretación,
- los delirios pasionales, entre los que incluye al delirio de reivindicación, de celos y la erotomanía,
- la constitución paranoica o carácter paranoico.

Hemos escogido privilegiar la presentación clínica de estas formas de la paranoia a partir de sus autores clásicos y profundizar sus desarrollos en el capítulo siguiente, a fin de poner de relieve aquello que Kraepelin y Gatan de Clérambault advirtieron: la constante dificultad diagnóstica inicial. "Es clásico que no se puede establecer un diagnóstico basándose en un único signo" (Gatan de Clérambault, 1921: 49).

Referencias bibliográficas

- Althusser, L. (1993). *El porvenir es largo. Los hechos*. Buenos Aires: Ed. Destino.
- Álvarez, JM. (1985). Recorrido por los clásicos de la paranoia y reflexiones nosológicas que de éste dimanar: Paranoia y esquizofrenia (1). *Cuadernos de Psicología*, 1985, II: 125-153.
- Álvarez, JM. (1997). De nuevo la paranoia. En JM Álvarez J. M. & F. Colina. *Clásicos de la paranoia*. Madrid: Editorial Dor.
- Álvarez, JM. (2013). ¿Qué fue de la paranoia? En JM Álvarez. *Estudios sobre la psicosis*. Madrid: Red Ediciones.
- Bercherie, P. (1981). *Los Fundamentos de la Clínica. Historia y Estructura del Saber Psiquiátrico*. Buenos Aires: Manantial.
- Coromines, J. (1961). *Breve diccionario etimológico de la lengua castellana*. Madrid: Gredos.
- De Battista J. (2006). Folie à deux- folie simultanée: el problema de la transmisión de la locura y el lazo social en la psicosis. *Memorias de las XIX Jornadas de residentes de Psicología y Psiquiatría de la Provincia de Buenos Aires. VI Jornadas de residentes de Salud Mental de la provincia de Buenos Aires "Modalidades de la urgencia"*. Volumen 1: 407-414.
- Gaupp, R. (1914). *El Caso Wagner*. Madrid: Asociación Española de Neuropsiquiatría.
- Gaupp, R. (1920). El caso Wagner. Una catamnesis, a la vez que una aportación a la enseñanza de la paranoia. En JM. Álvarez & F. Colina. (1997). *Clásicos de la paranoia*. Madrid: Editorial Dor.

- Gómez de Silva, G. (1985). *Breve diccionario etimológico de la lengua española*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Jaspers, K. (1913). *Psicopatología general*. Buenos Aires: Beta, 1977.
- Kraepelin, E. (1899). Paranoia. En E. Kraepelin. *Dementia praecox y paranoia*. Selección de textos por Carbone, N. y Piazzese, G. Traducción del capítulo X. Paranoia a cargo de Martín, J. La Plata: De la Campana.
- Kraepelin, E. (1900). *Introducción a la clínica psiquiátrica*. Madrid: Nieva.
- Kraepelin, E. (1913). *La paranoia*. Traducción de Vicente Felipe Donnoli. Buenos Aires: Salerno, 2012.
- Kraepelin, E. (1915). *Psiquiatría. Un manual para estudiantes y médicos*. Cap. XIV: "La locura paranoica". En JM. Álvarez & F. Colina. *Clásicos de la paranoia*. Madrid: Editorial Dor.
- Lacan, J. (1931). Estructura de las psicosis paranoicas. *El Analicón*, nº 4, 1987: 5-20.
- Lacan, J. (1932). *De la psicosis paranoica en sus relaciones con la personalidad*. México: Siglo XXI, 1985.
- Lacan, J. (1955-56). *El seminario de Jacques Lacan. Libro III. Las psicosis*. Buenos Aires: Paidós, 2010.
- Lacan, J. (1973). Introducción a la edición alemana de un primer volumen de los *Escritos*. En J. Lacan. *Otros escritos*. Buenos Aires: Paidós, 2010.
- Lester, G. (2017). Searching for the spectrum of the querulous. En W. Petherick & G. Sinnamon (comps.) *The Psychology of the criminal and antisocial behavior. Victim and offender perspectives*. London: Elsevier.
- Napolitano, G. & cols. (2002). *El debate sobre la paranoia en la primera mitad del siglo XX*. La Plata: De la Campana.
- Neisser, C. (1891). Disertación sobre la paranoia desde el punto de vista clínica. En JM. Álvarez & F. Colina. *Clásicos de la paranoia*. Madrid: Editorial Dor, 1997.
- Quinet, A. (2016). *Psicosis y lazo social. Esquizofrenia, paranoia*. Buenos Aires: Letra Viva.
- Séglas, J. (1900). La demencia paranoide. En JC Stagnaro (comp.) *Alucinar y delirar Tomo II*. Buenos Aires: Polemos, 2006.
- Sérieux, P. y Capgras, J. (1909). *Las locuras rasonantes. El delirio de interpretación*. La Plata: De la Campana.
- Universidad de Salamanca. (2018). *Diccionario médico-biológico, histórico y etimológico*. Recuperado de: <https://dicciomed.usal.es/palabra/catatimia>

CAPÍTULO 16

Formas paranoicas de la experiencia

Julia Martin, Jesica Varela

y Nicolás Maugeri

En este capítulo nos centraremos en recuperar las descripciones clínicas clásicas de este variado campo de la paranoia. Ya adelantamos al final del capítulo anterior que la tripartición realizada por Lacan en 1931 nos resulta apropiada hoy en día y sintetiza adecuadamente los aportes de los psiquiatras clásicos. La misma distingue dentro de las psicosis paranoicas a tres formas diferenciales de presentación:

- el delirio interpretativo, cuya delimitación ya abordamos en el capítulo anterior con Kraepelin y que precisaremos en éste con Sérieux, Capgras y de Clérambault,
- los delirios pasionales (reivindicación, celos, erotomanía),
- la constitución paranoica o carácter paranoico.

Las dos primeras son variedades delirantes, mientras que la última plantea la cuestión de la matriz del delirio o su esbozo. Lacan (1931) ofrece la metáfora fotográfica por la cual el carácter paranoico constituiría el negativo del cual se puede obtener la foto positiva del delirio, como si el carácter fuera el molde del que sale la estatua del delirio (p. 9). En el delirio hallaría expresión lo que se encuentra en estado larvado en el carácter o constitución paranoica.

La tripartición propuesta, que puede resultar muy sencilla, compendia años de elaboraciones de distintos autores pertenecientes sobre todo a la escuela francesa. De ahí que resulte indispensable para su transmisión la reconstrucción somera de cómo se fueron distinguiendo y caracterizando estas formas de presentación de la paranoia. Es importante aclarar también que Lacan pretendía incluir una nueva forma de paranoia -la paranoia de autopunición- en lo que se considera el edificio de oro de la psiquiatría clásica. Hay que decir también que esta nueva forma no llegó a incorporarse en el lenguaje clínico habitual de los psiquiatras, aunque de tanto en tanto es tema de debate entre los psicoanalistas.

Comenzaremos el recorrido por los aportes de Paul Sérieux y Joseph Capgras, quienes demarcaron dos tipos de delirios con características diferenciales dentro de la paranoia: el delirio de interpretación y el delirio de reivindicación. Posteriormente Gatian de Clérambault complejiza esta distinción al incluir no sólo el delirio de reivindicación, sino también el delirio de celos y la erotomanía como formas de la paranoia que pasaron a llamarse "pasionales", a dife-

rencia de las interpretativas. Por último, la cuestión del carácter se había impuesto como temática inherente a la paranoia desde los desarrollos de Kraepelin y su hipótesis de las causas endógenas o constitucionales. Pero conoció elaboraciones posteriores en la escuela francesa, tendientes a homogeneizar la noción de paranoia con la de personalidad paranoica. Montassut y Génil-Perrin son los antecedentes de importancia al respecto, ya que postulan una hipertrofia del yo junto a falta de autocrítica y detallan los rasgos esenciales de esta constitución, que no es más que un tipo de carácter. Todos ellos se resumen para Montassut en una sola categoría: la psicorrigidez, que tiene un aspecto motor y un aspecto psíquico y es propia del carácter paranoico. Comenzaremos entonces por los dos primeros tipos de psicosis paranoicas en sus variedades delirantes: delirio interpretativo y delirio de reivindicación.

Mecanismos del delirio paranoico en Sérieux & Capgras

Estructura en red del delirio interpretativo

Desde 1902, como hemos antes introducido, dos clínicos franceses llamados Paul Sérieux y Joseph Capgras presentaron un ordenamiento en el campo de las paranoias. Delimitaron diferentes entidades clínicas a partir de situar el mecanismo que organiza la estructura del delirio. De este modo, desglosaron el campo de la locura al presentar dos clases distintas de delirio: el interpretativo y el reivindicativo, que clínicamente se asemejan a la descripción realizada por Kraepelin del delirio de interpretación y el delirio de querulancia, pero con mayor exhaustividad y riqueza en los detalles.

Es decir que encontramos aquí una convergencia o punto de coincidencia en las elaboraciones de autores que pertenecían a tradiciones teóricas diferentes. Recordemos que estas convergencias nos interesan en la medida en que nos permiten delimitar presentaciones clínicas consistentes que pueden diferenciarse de otras, descriptas con características similares en distintos autores, y que no se reducen meramente a un afán clasificatorio y nominal.

El trabajo de investigación conjunto de ambos clínicos los condujo a publicar en 1909 un libro titulado *Las locuras razonantes. El delirio de interpretación*, de enorme contribución a la psicopatología de la paranoia. Los delirios sistematizados crónicos que van a estudiar se caracterizan por no reposar sobre un mecanismo alucinatorio, sino que parten de interpretaciones delirantes. Inicialmente estos autores se ocupan aquí de definir a la **interpretación delirante**, mecanismo propio del delirio de interpretación:

Es un razonamiento falso que tiene como punto de partida una sensación real, un hecho exacto, el cual en virtud de asociaciones de ideas ligadas a las tendencias, a la afectividad, toma, con ayuda de inducciones o deducciones erróneas, una significación personal para el enfermo, empujado de modo invencible a relacionar todo con él mismo (Sérieux & Capgras, 1909: 10).

Destacamos que los autores resaltan el componente de significación personal o autorreferencia mórbida como esencial. En función de este concepto distinguen la interpretación delirante de la ilusión y de la alucinación. Estas últimas son consideradas como trastornos sensoriales: la alucinación es una percepción sin objeto y la ilusión una percepción inadecuada del objeto.⁸² También la distinguen de la idea delirante, en tanto esta última es una creación ideica que no parte de un hecho observado, sino que es "creada en su totalidad" (Sérieux & Capgras, 1909: 8).

En su afán por otorgar precisión y nitidez clínica a la interpretación delirante, se ocupan también de separarla de la **interpretación falsa o error**, tarea mucho más ardua, dado el carácter deductivo erróneo con el que atribuyen significaciones tanto las interpretaciones delirantes como las erróneas. Sin embargo, logran esclarecer algunas diferencias. Así, en tanto la interpretación errónea es en la mayoría de los casos rectificable, la interpretación delirante es incorregible. La interpretación delirante pertenece al terreno de lo patológico, el error no. La interpretación errónea permanece aislada, circunscripta, mientras que la interpretación delirante tiende a la difusión, a la irradiación, a expandirse y a incorporar ideas semejantes que van conformando un sistema; por ello se utiliza la metáfora de la red. Otra diferencia es que el error no tiene por objeto necesariamente al yo, mientras que la interpretación delirante sí lo tiene por objeto. La interpretación delirante tiende a realizarse, a orientar y a dominar la realidad.

Los autores se interesan entonces por la presentación clínica de las llamadas "interpretaciones delirantes sistemáticas crónicas", forma prevalente en los "interpretadores puros". Son sujetos que "ponen de relieve la asociación extraña de la razón y de la locura y merecen claramente el calificativo de 'locos razonantes'" (Sérieux & Capgras, 1909: 16). Es decir que los sujetos afectados por este delirio conservan fuera del mismo toda su vivacidad de espíritu con la que defienden sus convicciones, expresan recuerdos y establecen asociaciones.

La principal crítica de estos autores a lo que se conocía en ese entonces como delirios sistematizados (en la escuela francesa) o paranoia (en la escuela alemana) radica en que, hasta ese momento, la clasificación de los delirios que se incluían allí se realizaba en base a la naturaleza del sistema delirante y así se distinguían el delirio de celos, los delirios de persecuciones, los delirios de grandeza, el delirio místico, el delirio erótico y el delirio hipocondríaco. Según Sérieux y Capgras, al fundar esta clasificación simplista en un criterio tan superficial como el contenido de la temática delirante se terminaban agrupando hechos muy diversos. Es necesario para ellos recuperar las agrupaciones de síntomas características, su evolución típica y la modalidad de organización del delirio.

Con respecto a la causa, dividen el campo de los delirios crónicos sistemáticos en: "psicosis adquiridas" que, alterando la mentalidad del sujeto conducen a demencias,⁸³ y "psicosis constitucionales", que no modifican la personalidad ni conducen al deterioro. De estas últimas despren-

⁸² Cf. con la parte III sobre los fenómenos elementales.

⁸³ La demencia se suele definir como una debilitación global, crónica, progresiva, definitiva e irreparable de todas las funciones psíquicas. Cf. capítulo 24.

den el tipo de “psicosis crónica a base de interpretaciones” o “delirio de interpretación”, ya que la totalidad de los casos incluidos bajo este término se basan en interpretaciones delirantes.

Cabe aclarar que, si bien la interpretación delirante es un rasgo sobresaliente de esta entidad clínica, no es suficiente para otorgarle autonomía, ya que es común a otras psicosis. Por esta razón, los autores agregan otros criterios para caracterizar al delirio de interpretación como una psicosis crónica sistemática, donde la proliferación de múltiples interpretaciones progresivas determinan la organización de una novela delirante y compleja que puede dar lugar a reacciones transitorias. Las alucinaciones son poco frecuentes, la lucidez y actividad psíquica se mantienen a pesar del contenido delirante que, si bien es incurable, no evoluciona hacia el deterioro (Sérieux y Capgras, 1909).

En resumen, los criterios a partir de los cuales definen al delirio de interpretación son:

- la multiplicidad y organización de las interpretaciones delirantes,
- la ausencia o casi inexistencia de alucinaciones,
- la persistencia de la lucidez y de la actividad psíquica,
- la evolución por expansión progresiva de las interpretaciones,
- la incurabilidad sin demencia terminal (Sérieux & Capgras, 1909: 9).

Desde un punto de vista clínico, el delirio de interpretación se caracteriza por la presencia de dos órdenes de síntomas en apariencia contradictorios: los positivos y los negativos.

Los **síntomas positivos** se definen como las manifestaciones mórbidas del delirio, en los que es posible distinguir las concepciones delirantes y las interpretaciones delirantes. Las primeras se constituyen por ideas de persecución, ideas de grandeza, de celos, ideas místicas, ideas eróticas, ideas hipocondríacas, que parecen ser el síntoma principal sobre el cual se construye la novela del delirio, aunque tienen un valor contingente. Estas concepciones se mantienen en el terreno de lo posible y lo verosímil. En algunos casos se constituyen como dudas delirantes y frecuentemente son mantenidas en secreto o se revelan con reticencia.

Las interpretaciones delirantes tienen su punto de partida en hechos reales, a los que el interpretador desnaturaliza, traviste y amplifica, apoyándose en los datos de los sentidos y la sensibilidad interna. Las interpretaciones pueden ser de dos tipos: endógenas y exógenas. Las interpretaciones delirantes exógenas tienen su punto de partida en el mundo exterior, dando lugar a un verdadero delirio de significación personal:

Una mirada, una sonrisa, un gesto, los gritos y las canciones de los niños, la tos o los esputos de un vecino, el cuchicheo de los que pasan a su lado, los fragmentos de papel hallados en la calle, una puerta abierta, una nimiedad sirve de pretexto a las interpretaciones (Sérieux & Capgras, 1909: 27).

Los enfermos no dejan de encontrar coincidencias en los hechos producidos por azar, las interpretaciones se vuelven ilimitadas, y con su "clarividencia interpretativa saben desentrañar la verdad y las relaciones secretas de las cosas" (Sérieux & Capgras, 1909: 27).

Las interpretaciones delirantes endógenas encuentran su fuente en la observación introspectiva del estado orgánico y de la cenestesia, por la cual son los fenómenos fisiológicos los que están en el origen de la interpretación o la misma se halla ligada a lo mental: ciertos estados de conciencia o la exhumación de recuerdos sirven para generar interpretaciones.

De esta manera, las interpretaciones no sólo afectan al presente del sujeto, sino que pueden extenderse a su pasado, configurando una suerte de delirio retrospectivo. Recordemos que Kraepelin ya había planteado que las ilusiones de la memoria, junto con las autorreferencias, constituirían los mecanismos principales del delirio interpretativo. Pueden presentarse también falsos reconocimientos que Capgras había delimitado en otro artículo bajo la denominación "ilusión de Sosías".⁸⁴ El trabajo interpretativo conduce a una completa transformación de la concepción del mundo que se vuelve mórbida por la expansión de las interpretaciones autorreferenciales. Todo se vuelve "*tua res agitur*" ("asunto de tu interés") (Sérieux & Capgras, 1909: 30).

Los **síntomas negativos** refieren a la ausencia de determinados indicadores que evidencien el deterioro del intelecto: afectos, lenguaje y conductas. En forma principal los autores mencionan la ausencia de trastornos en la vida afectiva (en el humor, en los sentimientos, en los afectos), en la vida intelectual (no hay alteración de la conciencia, ni de la memoria, ni del curso del pensamiento) y la ausencia de trastornos sensoriales. Es decir, conservación de las facultades mentales y ausencia de alucinaciones. La falta de perturbaciones de la afectividad permite separar esta forma clínica del campo de las manías, melancolías y psicosis maníaco-depresivas. En tanto que la ausencia de deterioro psíquico y de alucinaciones permite diferenciar a la paranoia de las esquizofrenias.

Respecto de las causas, señalan que su origen debe ser buscado en la predisposición psicopática, en anomalías del desarrollo cerebral.

La **evolución del delirio de interpretación**, crónica y progresiva, sin demencia ni curación, prosigue tres etapas: incubación insidiosa, período de estado o sistematización y el período terminal, en el cual la actividad creativa e interpretativa generalmente disminuye. La sistematización progresiva es lo central de la evolución crónica del delirio.

La siguiente viñeta clínica constituye un extracto de un caso trabajado por los autores en el libro, y permite analizar los rasgos centrales del delirio interpretativo.⁸⁵

Se trata de la Señora X, de 35 años de edad, casada desde los 20 años con un funcionario en una unión arreglada por conveniencia. Poco después de haber contraído matrimonio, comienza a manifestarse un primer síntoma de su malestar: la desconfianza, que recae principalmente en la figura de su esposo. Esta desconfianza se expresa en toda una serie de interpretaciones y concepciones delirantes. Así, luego de tomar una taza de café sin darse cuenta, acusa a su marido de habérsela bebido. En otra ocasión, en que su marido enferma gravemente, la naturaleza de los medicamentos y la localización de la enfermedad en los órganos sexuales son una prueba irrefutable para ella de que su marido es "un sifilítico y homosexual". Por

⁸⁴ Cf. capítulo 11.

⁸⁵ El caso de la señora X se desarrolla en extenso en el libro citado. Corresponde a la observación 1 que se presenta en las páginas 13 a 25.

ese entonces, se queja de ser perseguida por él, quien, una vez curado “arma farsas de un gusto dudoso y amenazas”. Dice que su marido quiere hacerla desaparecer para evitar sus revelaciones. Se queja de que él abre sus armarios, sus cajones, desordena su ropa interior y sus papeles, con el fin de obligarla a irse de la casa que comparten. También la siguen en la calle, le hacen signos. Es su suegra quien la hace seguir a fin de obtener indicaciones precisas para conseguir el divorcio.

En la evolución del cuadro persisten toda una serie de interpretaciones delirantes exógenas: si la Señora X oye un ruido, es que están escuchando detrás de la puerta; una carta retrasada es que ha sido interceptada; un ladrillo que cae por el hueco de la chimenea es señal de que intentan meterse en su casa. También forman parte del delirio interpretaciones endógenas: cierta vez que enferma de una gripe, se le impone la idea de que su marido la contagió de sífilis.

Con la evolución del delirio, las concepciones delirantes de tipo persecutorio continúan: ocultan los objetos para despertar su intriga, agujerean un muro, imprimen especialmente para ella una edición de diario, como lo prueban los artículos extraños y anuncios que la aluden para enloquecerla, exasperarla y extraviarla haciéndole creer que ha perdido la razón. Finalmente intentan arrastrarla al suicidio mediante actitudes burlonas o amenazantes. Desesperada, la Señora X piensa en pegarse un tiro, pero termina por tomarse un vaso de licor. Apenas restablecida, nuevamente emerge la intriga: encuentra en una habitación un papel que alude irónicamente a su situación: “las personas de bien, a menudo, son víctimas de los malvados”. Más adelante, convencida de que su marido quiere sacársela de encima para casarse con otra mujer, interpreta eróticamente una broma que él hace sobre una persona de color y afirma que su marido quiere “que un negro la posea”.

Se refugia entonces en la casa de un familiar, exaltada, habla de suicidio, de gente que la sigue, del hipnotismo al que cree que fue sometida, por lo cual la encierran y dan aviso a su marido. La Señora X se arroja por la ventana del entresuelo, contexto en el que sobreviene una primera internación. Si bien la influencia del aislamiento parece mejorarla y es externada, las interpretaciones delirantes se multiplican: todos los actos, todas las palabras de su marido son alusiones, amenazas y tentativas dirigidas hacia ella. En ocasiones, siente que la fuerzan a tomar medicamentos para envenenarla. La conducta de su marido le resulta extraña, hostil. Él regresa al hogar con ropa impregnada de perfumes sugestivos, lo escucha caminar en las noches, por la habitación pegada a la suya, hechos que interpreta en forma celotípica, como prueba de que él espera a la mucama o a otro hombre.

Acosada por sus preocupaciones, la Señora X reclama a un juez el divorcio y le da cinco tiros de revólver a su marido. Nuevamente es internada. Una demanda perentoria de su marido para que vuelva a su hogar, le hace pensar que éste ha hecho todo lo posible para mantenerla internada. Acepta perdonar, abandonar la idea del divorcio y volver a su casa sólo si cesan las “farsas y amenazas”. A pesar de esto, continúa creyendo ser el blanco de las maquinaciones de su marido. Deja de salir, su salud se deteriora, y sus malestares físicos son interpretados como otra prueba de los atentados de los que es víctima. Un nuevo acto de violencia contra su